GUIA MÉDICO CONFIDENCIAL

Estética Íntima Masculina: Preenchimento Peniano & Botox Íntimo

Informação médica transparente sobre espessamento peniano com Ácido Hialurônico (Urofill™), Toxina Botulínica peniana/escrotal, anatomia de segurança e resultados reais.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE GUIA CLÍNICO:

- Como funciona o Preenchimento Peniano com Ácido Hialurônico no plano fascial seguro (sem atingir os corpos cavernosos);
- Por que o Ácido Hialurônico é biocompatível e 100% reversível — e por que o PMMA jamais deve ser utilizado;
- Botox Peniano e Escrotal (Scrotox): indicações para retração no frio/esporte, conforto térmico e estética escrotal;
- Como é o preparo, a anestesia local sem dor no consultório e o cronograma de recuperação passo a passo.

Dr. Felipe de Bulhões

MÉDICO · Urologista & Cirurgião Geral · CRM-SP 202.291 | RQE 146538 / 114019
Residência em Urologia pelo Instituto D'Or de Ensino e Pesquisa (IDOR-SP) · Titular do CBC (TCBC)

TCBC · IDOR-SP · SBU · AUA · EAU
SÃO PAULO & CAMPINAS

Olá! Sou o Dr. Felipe de Bulhões, médico Urologista (IDOR) e Cirurgião Geral (TCBC).

A insatisfação com o calibre peniano (especialmente em flacidez) ou o desconforto com a retração genital no frio e no esporte são queixas extremamente comuns, mas que muitos homens evitam discutir por receio de julgamento ou falta de informação médica séria. Preparei este guia técnico para explicar, com rigor anatômico e total transparência, o que a urologia moderna oferece com segurança comprovada.

1. Preenchimento Peniano com Ácido Hialurônico: Anatomia e Segurança

O preenchimento peniano médico é um procedimento minimamente invasivo, realizado em consultório sob anestesia local, cujo objetivo é promover o **aumento simétrico da circunferência (espessura/calibre)** do pênis tanto em estado de flacidez quanto em ereção, além de reduzir a retração em repouso pelo efeito de peso/sustentação.

Onde o produto é depositado? Com o uso de microcânulas atraumáticas de ponta romba, o gel de Ácido Hialurônico reticulado de alta coesividade é depositado exclusivamente no plano virtual entre a **Fáscia de Dartos e a Fáscia de Buck** (camadas superficiais de revestimento). Os **corpos cavernosos** (estruturas profundas responsáveis pela ereção) e a **uretra** permanecem 100% intactos.

CRITÉRIO DE SEGURANÇA	ÁCIDO HIALURÔNICO MÉDICO (PADRÃO-OURO)	PMMA / SILICONE (CONTRAINDICADO)
Biocompatibilidade	Substância naturalmente presente no organismo humano; integração tecidual macia e natural ao toque.	Polímero plástico permanente (acrílico); reconhecido pelo corpo como corpo estranho definitivo.
Reversibilidade	**100% reversível** a qualquer momento através da enzima Hialuronidase se necessário ajuste fino.	Irreversível; a remoção exige cirurgias complexas com perda de pele e tecido saudável.
Planejamento & Retoque	Permite sessões progressivas e personalizadas (ganho médio de 2 a 4 cm de circunferência conforme anatomia).	Risco elevado de migração, nódulos pétreos (granulomas), infecção tardia e deformidade peniana.
Função Erétil & Sensibilidade	Preserva integralmente a rigidez erétil, a sensibilidade glândular/cutânea e o prazer sexual.	Alto índice de dor crônica na ereção e encarceramento cicatricial da pele peniana.

2. Botox Peniano e Escrotal (Toxina Botulínica Tipo A)

A aplicação de **Toxina Botulínica Tipo A** na região genital masculina (frequentemente chamada de *Scrotox* no escroto e Botox Peniano/Dartos na haste) atua promovendo o relaxamento temporário e seguro das fibras musculares lisas superficiais (**Músculo Dartos**) e do músculo cremaster:

Botox Peniano (Relaxamento do Dartos)

- Reduz a hiperatividade do reflexo de retração peniana causada por frio, estresse, ansiedade ou atividade física ("síndrome do vestiário");
- Proporciona maior comprimento aparente e relaxamento em flacidez;
- Pode ser associado ao preenchimento com Ácido Hialurônico para otimizar a acomodação do gel.

Botox Escrotal (Conforto & Estética)

- Suaviza a rugosidade excessiva da bolsa escrotal e permite que os testículos fiquem posicionados de forma mais baixa e confortável;
- Controla a **hiperidrose escrotal/inguinal** (suor excessivo, atrito e desconforto térmico ao usar roupas sociais ou treinar);
- Alivia quadros selecionados de dor escrotal crônica por espasmo muscular.

3. Passo a Passo do Procedimento e Recuperação

Todo o protocolo é conduzido pessoalmente pelo Dr. Felipe de Bulhões em ambiente médico estéril, com privacidade total e sem necessidade de internação hospitalar:

FASE DO PROTOCOLO	COMO FUNCIONA NA PRÁTICA
1. Consulta & Planejamento	Avaliação anatômica presencial (elasticidade da pele, presença ou não de postectomia/circuncisão prévia, simetria da haste) e alinhamento realista de volume (quantidade de seringas/ml) e objetivos.
2. Anestesia Local Sem Dor	Bloqueio anestésico local na base peniana (semelhante a uma anestesia odontológica leve). O procedimento dura cerca de **40 a 50 minutos** com conforto absoluto.
3. Retorno à Rotina	O paciente sai caminhando normalmente do consultório no mesmo dia e pode retornar ao trabalho administrativo/escritório imediatamente.
4. Cuidados Pós-Procedimento	Abstinência sexual e de atividades físicas intensas por **10 a 14 dias**, uso de cueca de sustentação orientada e retorno presencial de revisão para avaliação da simetria e acomodação do produto.

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO NATURAL

No preenchimento peniano com Ácido Hialurônico de alta densidade, a durabilidade média varia de **18 a 24 meses** (com absorção lenta e gradual, além de estímulo de colágeno endógeno na fáscia, mantendo parte do ganho estrutural a longo prazo). Já a Toxina Botulínica apresenta duração média de **4 a 6 meses** por aplicação.

Checklist de Identificação: Este Protocolo é Indicado para Você?

AUTOAVALIAÇÃO CLÍNICA

- ☐ Deseja aumentar a circunferência (espessura/calibre) peniana com resultado natural e proporcional;
- ☐ Busca um procedimento não cirúrgico, realizado em consultório, com ácido hialurônico 100% seguro;
- ☐ Deseja melhorar a autoconfiança íntima mantendo 100% da função erétil e da sensibilidade;
- ☐ Sente incômodo com a retração do pênis em repouso (no frio, piscina, academia ou vestiário);
- ☐ Apresenta suor excessivo (hiperidrose) ou contração desconfortável na bolsa escrotal;
- ☐ Valoriza ser atendido diretamente por Cirurgião Urologista Titular (TCBC / SBU / EAU).

Próximo passo seguro: A indicação exata de volume (ml) e a associação entre Ácido Hialurônico e Botox Íntimo dependem do exame físico individualizado em consulta médica confidencial.

4. Perguntas Frequentes (Dúvidas Reais de Consultório)

O pênis fica com aspecto artificial ao toque?

Não. Utilizamos Ácido Hialurônico específico de alta coesividade depositado abaixo da Fáscia de Dartos. Após o período inicial de acomodação (2 semanas), a textura é uniforme, simétrica e indistinguível do tecido natural.

É necessário ter feito postectomia (circuncisão)?

Não é obrigatório, mas o excesso acentuado de prepúcio é avaliado na consulta para definir a distribuição ideal do produto e evitar acúmulo distal, garantindo resultado estético harmônico.

Locais Oficiais de Atendimento & Teleconsulta

São Paulo — Clinovi Paulista

Av. Paulista, 1048, 18º andar — Bela Vista, São Paulo - SP

São Paulo — Clinovi Pinheiros

Av. Rebouças, 2636 — Pinheiros, São Paulo - SP

Campinas — Campinas Day Hospital

Av. Benjamin Constant, 1991 — Cambuí, Campinas - SP

Campinas — Hospital São Luiz Campinas (Rede D'Or)

Av. Andrade Neves, 863 — Centro, Campinas - SP · + Teleconsulta

Próximo Passo: Avaliação Médica Individualizada

Deseja discutir seu caso com discrição absoluta, precisão diagnóstica e plano terapêutico sob medida? Nossa equipe de atendimento está pronta para orientar seu agendamento presencial ou por teleconsulta.

Falar no WhatsApp: (11) 98112-4455

Agendar pelo Site Oficial

Ciência • Saúde • Discrição • Resultados • Masculinidade • Longevidade

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS & CONFORMIDADE ÉTICA (RESOLUÇÃO CFM Nº 2.336/2023)

1. Yang DY, Ko K, Lee WK, et al. Hyaluronic Acid Filler Injection for Penile Augmentation: A Review of Anatomic Planes, Efficacy and Safety. Sex Med Rev.
2. El-Shaer W, Ghanem H, et al. Botulinum Toxin A in Andrology and Male Genital Aesthetics: Clinical Applications and Safety Profile. J Sex Med.
3. European Association of Urology (EAU). Guidelines on Sexual and Reproductive Health — Penile Size Abnormalities and Dysmorphophobia, 2025/2026.
4. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 2.336/2023. Todo procedimento médico possui indicações, limites anatômicos e riscos que são avaliados individualmente em consulta presencial.